SENTENÇA

[Fornecimento de medicamentos]
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
0802448-84.2025.8.15.0181
AUTOR: J. A. D. A. N., ELIZANGELA TOLENTINO DE ANDRADE SILVA
REU: UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Visto etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais ajuizada inicialmente por JOSÉ ÂNGELO DE ANDRADE NETO JOSÉ, então menor impúbere nascido em 13 de novembro de 2009, representado legalmente por sua genitora ELIZANGÊLA TOLENTINO DE ANDRADE SILVA, em face da operadora de plano de saúde UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A parte autora relatou que o Requerente, à época com 15 (quinze) anos de idade, era portador de Neuropatia Não Especificada (CID 10 – G 62.9) e se encontrava internado no Hospital Alberto Urquiza Wanderley (HAUW), unidade hospitalar pertencente à rede da Requerida (ID 110911023). Argumentou que a operadora de saúde dispunha de uma unidade hospitalar especificamente destinada ao atendimento pediátrico, o Hospital Pediátrico Unimed (HPU), cujo limite de atendimento se estendia a pacientes com até 18 (dezoito) anos de idade, sendo este o local ideal e recomendado pelo corpo clínico que inicialmente assistia o paciente. A petição referiu a existência de expressa solicitação médica para a transferência (ID: 110911035) e alegou que a Diretoria do HPU vinha se recusando a efetivar o procedimento, sem apresentar justificação plausível, configurando uma negativa tácita e infundada.

Demandou, em sede de tutela de urgência, a imediata determinação judicial para que a Promovida autorizasse e efetivasse a transferência do menor para o HPU, sob pena de multa diária e, no mérito, pugnou pela confirmação da tutela e pela condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), embasando tal pedido na angústia e aflição causadas pela inércia da operadora em garantir o direito à saúde e à vida do menor.

Tutela de Urgência deferida (ID 110982868) e cumprida em 25/04/2025 (ID: 111724977).

Em sede de contestação, a promovida arguiu a total improcedência dos pedidos.

Inicialmente, a Ré buscou desconstituir a premissa da necessidade de intervenção judicial, alegando que o pedido inicial se fundava em um panorama superado, visto que o Autor, devido ao seu quadro clínico de alta complexidade e internação prolongada (mais de 400 dias,

incluindo período no HPU), era assistido em uma unidade de maior porte e com infraestrutura mais adequada (HAUW). A Requerida enfatizou que, se houve uma solicitação inicial de transferência, o seu corpo técnico imediatamente agiu para promover uma reorganização na rotina terapêutica no HAUW, incluindo formalmente supervisão pediátrica direta.

Para comprovar tal diligência, a Ré anexou ata de reunião datada de 11/04/2025 (portanto, na data do ajuizamento da ação), realizada com a participação da genitora e da equipe multidisciplinar, que teve como pauta justamente a "PERMANÊNCIA DO PACIENTE JOSÉ ÂNGELO NO HAUW" e a adequação do suporte pediátrico (ID 112487747).

Ademais, a Requerida apresentou um parecer técnico posterior, de 18 de abril de 2025, subscrito pelo próprio médico solicitante (Dr. Antonio Campanile Neto, ID: 112487746), no qual este atestava que o paciente se encontrava *clinicamente estável* e bem assistido no HAUW, e que a transferência para o HPU era inviável naquele momento devido à lotação máxima associada à sazonalidade de infecções respiratórias, levantando o risco de ruptura na continuidade terapêutica. A contestação concluiu pela inexistência de ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável, classificando a situação como eventual aborrecimento decorrente de divergência na interpretação de critérios técnicos de alocação de recursos, máxime porque o atendimento nunca foi negado, mas sim readequado.

Apresentada réplica à Contestação (ID 114796208), a parte Autora contestou os argumentos da Ré, em especial o parecer técnico posterior, enfatizando a contradição do Dr. Antonio Campanile Neto, que, em curto espaço de tempo, solicitou a transferência e depois a desaconselhou. A Réplica sustentou que a manobra da Requerida demonstrou insegurança técnica ou interferência administrativa, buscando legitimar uma inércia que só cessou após a intervenção judicial.

Durante a fase de instrução, a genitora protocolou petição (ID 124933242) comunicando o fato superveniente do óbito de José Ângelo de Andrade Neto, ocorrido em data posterior à transferência hospitalar.

Ainda, a genitora, agora como sucessora processual do de cujus, requereu: a) a extinção parcial do feito sem resolução do mérito quanto à obrigação de fazer (transferência hospitalar) por perda do objeto; e b) o aditamento da inicial cumulado com a substituição processual para que ELIZANGÊLA TOLENTINO DE ANDRADE SILVA passasse a figurar como Autora em nome próprio, pleiteando indenização pelos danos morais próprios e autônomos (dano em ricochete) que suportou em decorrência da conduta abusiva da operadora. (ID 124933242)

Em vista do estado do processo, com a obrigatoriedade de julgamento diante do fato superveniente e dos fatos controvertidos, e considerando que os autos se encontram devidamente instruídos pela vasta documentação juntada pelas partes, aptos a fundamentar uma decisão de mérito, passo à análise da causa.

É O BREVE RELATÓRIO.
PASSO A DECIDIR.

A presente demanda foi inicialmente articulada com dois pedidos: um de obrigação de fazer (transferência hospitalar) e outro de indenização por danos morais.

No tocante ao pleito de obrigação de fazer, o feito padece de perda superveniente de objeto. A tutela de urgência foi integralmente cumprida e, posteriormente, foi noticiado o falecimento do Autor (ID 124933242). A obrigação de fornecer assistência hospitalar e promover a transferência, que era o objeto da ação, tornou-se faticamente impossível. Consequentemente, o primeiro pedido cinge-se à carência de interesse processual superveniente, devendo ser extinto sem resolução de mérito, conforme o disposto no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Resta, portanto, a análise do pedido de indenização por danos morais. Esse pleito se desdobra em duas vertentes, dada a comunicação do óbito: primeiramente, o dano moral postulado na inicial, que era do próprio menor, vítima direta da alegada recusa; e, em segundo plano, o pedido de dano moral próprio e autônomo (dano ricochete) pleiteado pela genitora sobrevivente, visando a substituição processual e o aditamento da inicial para prosseguir com essa pretensão.

Considerando que a comunicação do óbito e o pedido de substituição/aditamento ocorreram após a fase postulatória (citação e contestação), **o mérito da indenização deve ser analisado estritamente com base nos fatos e fundamentos apresentados na petição inicial e contestação, que giram em torno da conduta da operadora em relação ao menor e aos seus representantes.**

Para a configuração do dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, é imperativa a comprovação de três elementos essenciais: *a conduta ilícita, o dano efetivo e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.*

Embora a situação do menor e o sofrimento inerente à sua condição de saúde sejam dignos de extrema consideração, a conduta da operadora, pautada na readequação e na justificativa de segurança do paciente frente à lotação do HPU, não revela o desrespeito ou a negligência grave capaz de gerar o abalo psíquico indenizável. O tratamento do menor não foi paralisado; ele continuou internado e, após a controvérsia, teve seu cuidado reestruturado para incluir a supervisão pediátrica no local onde se encontrava para, posteriormente, ser transferido.

O paciente JOSÉ ÂNGELO, em razão de seu histórico de internação prolongada e quadro de altíssima complexidade exigia não apenas acompanhamento pediátrico, mas uma robusta infraestrutura multidisciplinar, que o HAUW, como hospital de maior porte da rede, possuía em maior grau de prontidão e estabilidade, conforme consta da Contestação.

Alegar que a ausência de equipe pediátrica era absoluta no HAUW confronta-se com a rápida reorganização assistencial promovida pela operadora, inclusive com a comprovação da inclusão formal de supervisão pediátrica regular, ratificada em reunião com a genitora em 11 de abril de 2025, data exata do ajuizamento da ação.

A documentação colacionada demonstra, portanto, que a operadora de saúde agiu diligentemente, mesmo antes da intimação da decisão judicial, para adequar o atendimento às especificidades pediátricas do autor em sua unidade de internação atual, demonstrando comprometimento com a continuidade do tratamento no local onde o paciente já estava estável e adaptado.

Neste Juízo, a conduta da UNIMED se revela como exercício regular de direito e cumprimento do dever de gestão técnica da rede, nos termos do que dispõe o artigo 188, inciso I, do Código Civil. Não houve abandono assistencial, recusa de tratamento coberto ou óbice imposto por cunho estritamente financeiro ou burocrático, mas sim uma gestão do risco clínico do paciente em cenário de escassez momentânea de leito específico.

A pretensão indenizatória por danos morais, portanto, não encontra amparo nos elementos fáticos e jurídicos apresentados, ante a ausência de ato ilícito, visto que a operadora demonstrou ter acompanhado o caso com atenção e ter oferecido tratamento adequado, mesmo que havendo momentânea divergência técnica e operacional quanto ao local do internamento entre duas unidades próprias. Tal divergência, no contexto de alta complexidade e gestão hospitalar, não tipifica o ato ilícito gerador de dano moral indenizável.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, com base em tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO no que concerne ao pedido de obrigação de fazer (transferência hospitalar), em virtude da perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ainda, com base em tudo o mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, **JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL**.

Condeno os promoventes em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2.º), sendo vedada a compensação (art. 85, §14) e nas custas processuais, se houver.

Concedida a justiça gratuita, exequibilidade sobrestada, de acordo com o art. 98, §3º, do NCPC.

Decorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Interpostos embargos declaratórios, intime a parte embargada para, querendo, oferecer contrarrazões.

Por outro lado, caso seja interposto recurso de apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazoar em 15 (quinze) dias, caso tenha integrado a lide, e após remetam-se os autos ao E. TJPB, independente de nova conclusão.

Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

João Pessoa - PB , datado e assinado eletronicamente.
Luciana Celle G. de Morais Rodrigues
Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: LUCIANA CELLE GOMES DE MORAIS RODRIGUES
09/12/2025 20:33:43
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 128507832

25120920334349400000012

IMPRIMIR GERAR PDF